UNIVERSIDAD CENTRAL
DEL PARAGUAY

5TO SEMESTRE

Dra Alicia González

Anatomía Patológica

Unidad I:

Tema: Adaptación Celular

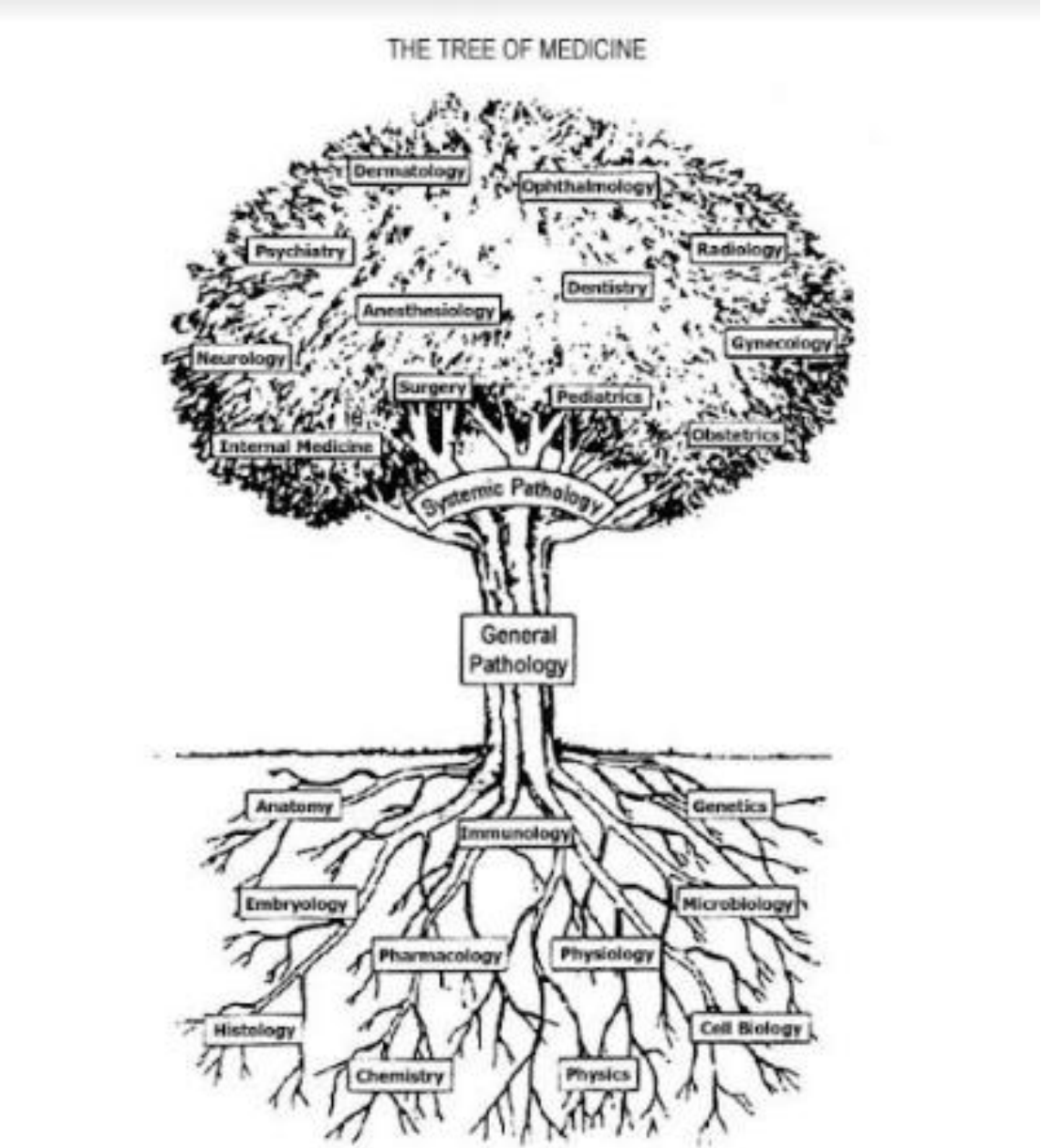
Cátedra De Anatomía Patológica

Dra. Alicia. González

ADAPTACION CELULAR

Dra. Alicia González/ ali.glez2303@gmail.com

Introducción a la patología



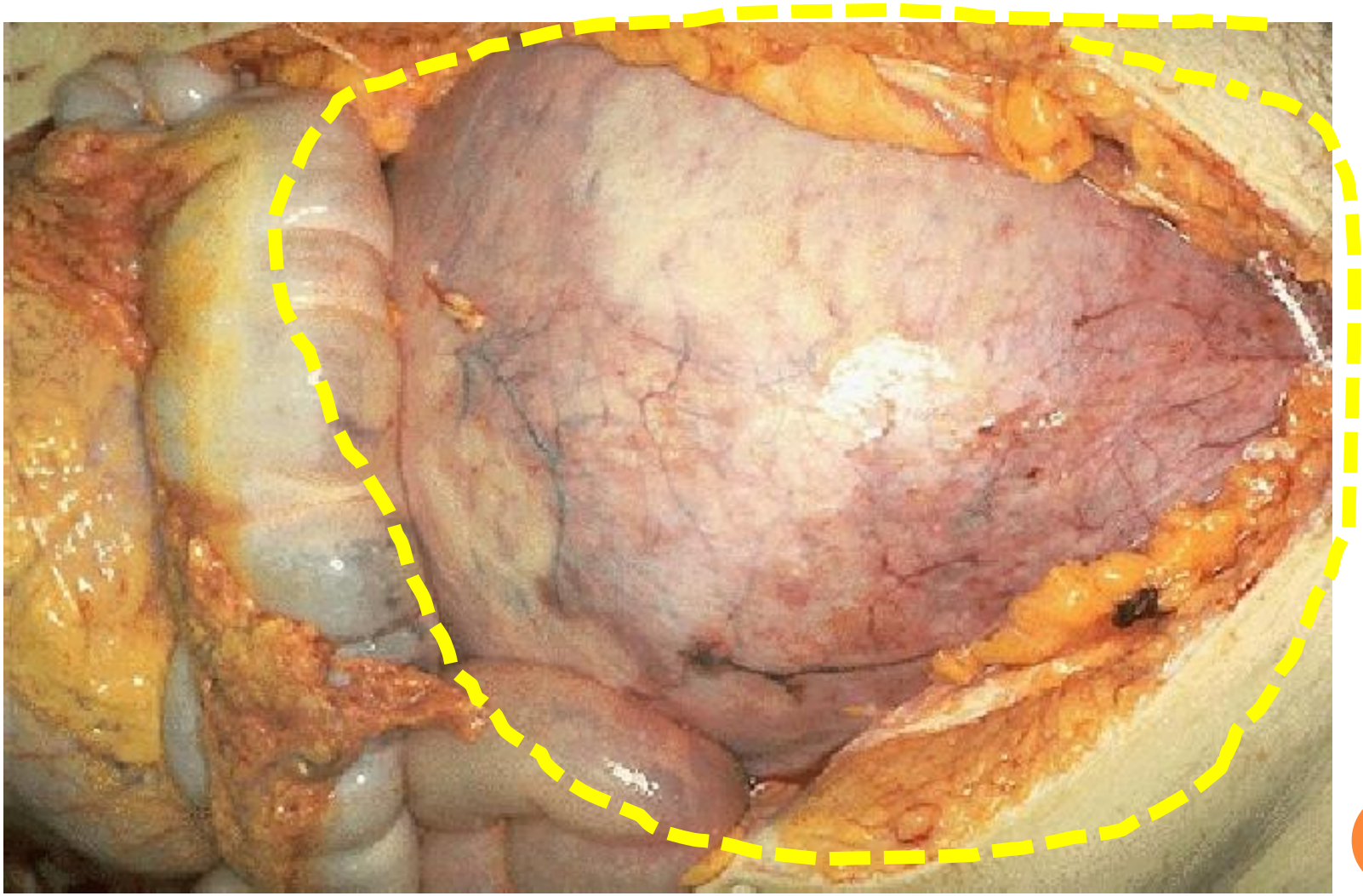
Adaptación Celular

HIPERPLASIA

Es el **aumento de número de células** en un órgano o tejido, dando lugar al **aumento de volumen** de este órgano o tejido.

Aunque la hiperplasia y la hipertrofia son 2 procesos distintos frecuentemente ocurren juntos y puede desencadenarse por el mismo estímulo externo

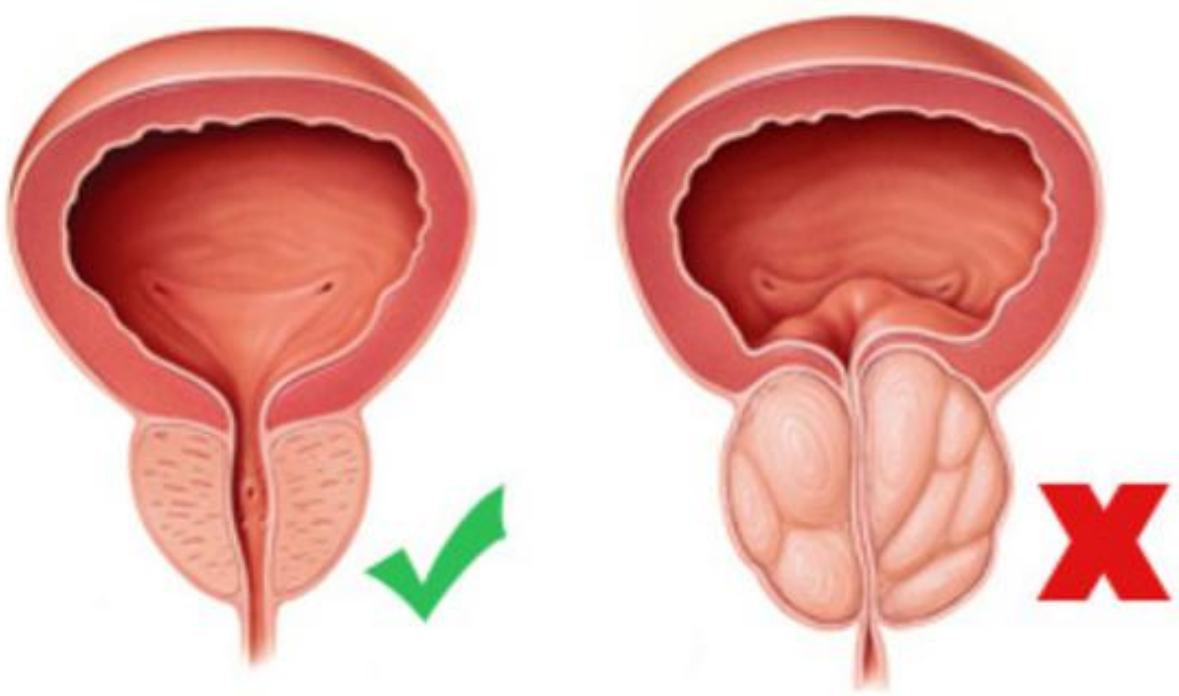
Ejemplo: **Crecimiento hormonal del útero** durante el embarazo que implica: número aumentado de células musculares y epiteliales y agrandamiento de esas células.



- Hiperplasia Prostática benigna(HPB):

Inducida por andrógenos

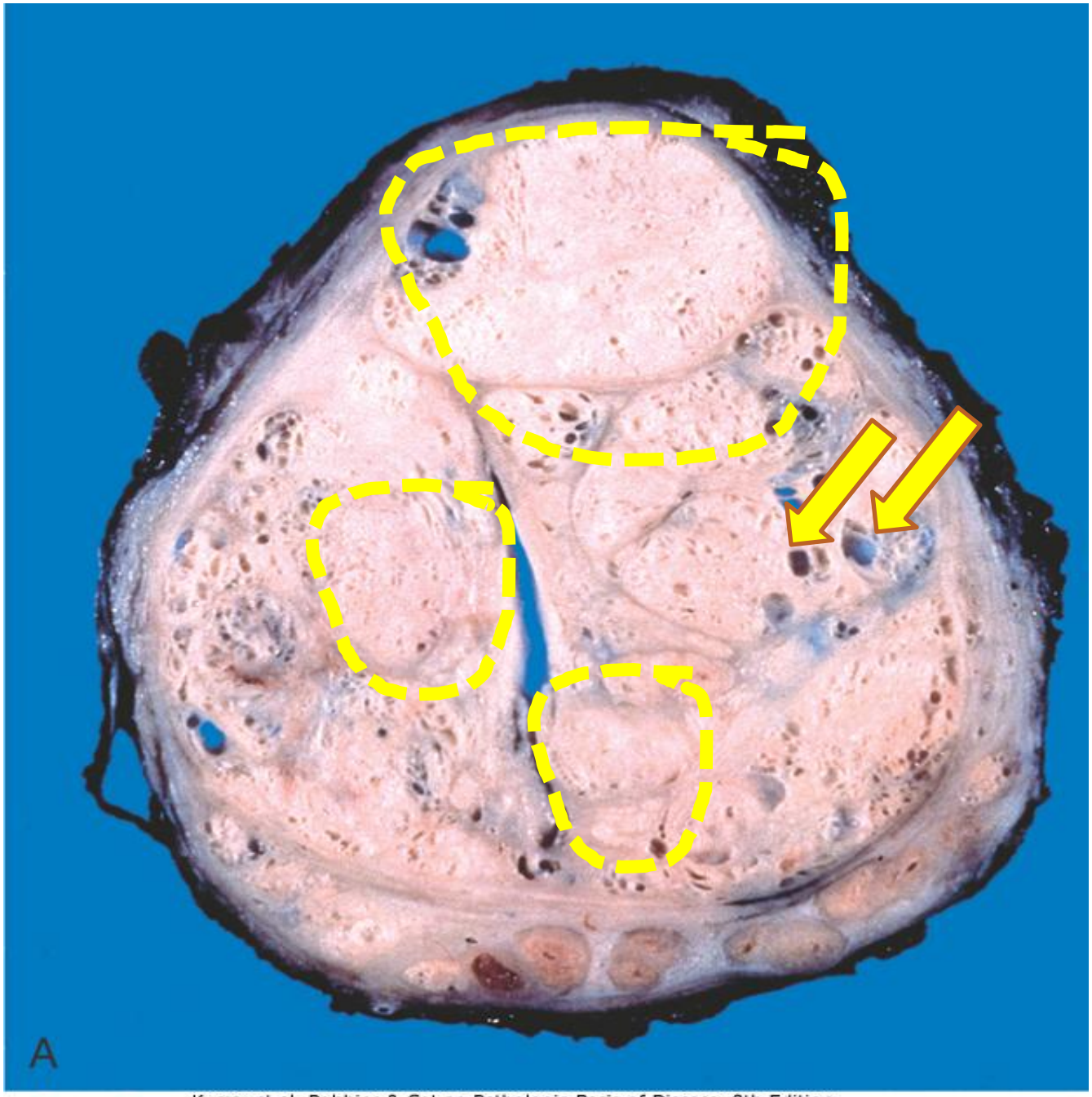
La hiperplasia constituye un terreno fértil en el cual puede surgir posteriormente una proliferación cancerosa



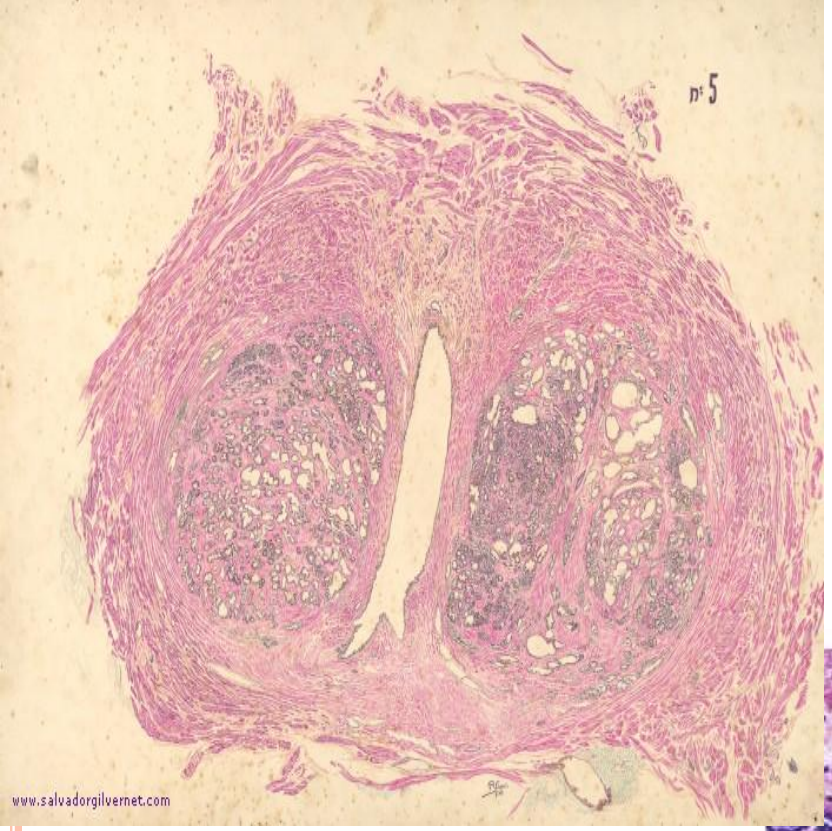




Dra. Alicia González/
ali.glez2303@gmail.com



Kumar et al: Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease, 8th Edition.
Copyright © 2009 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved.



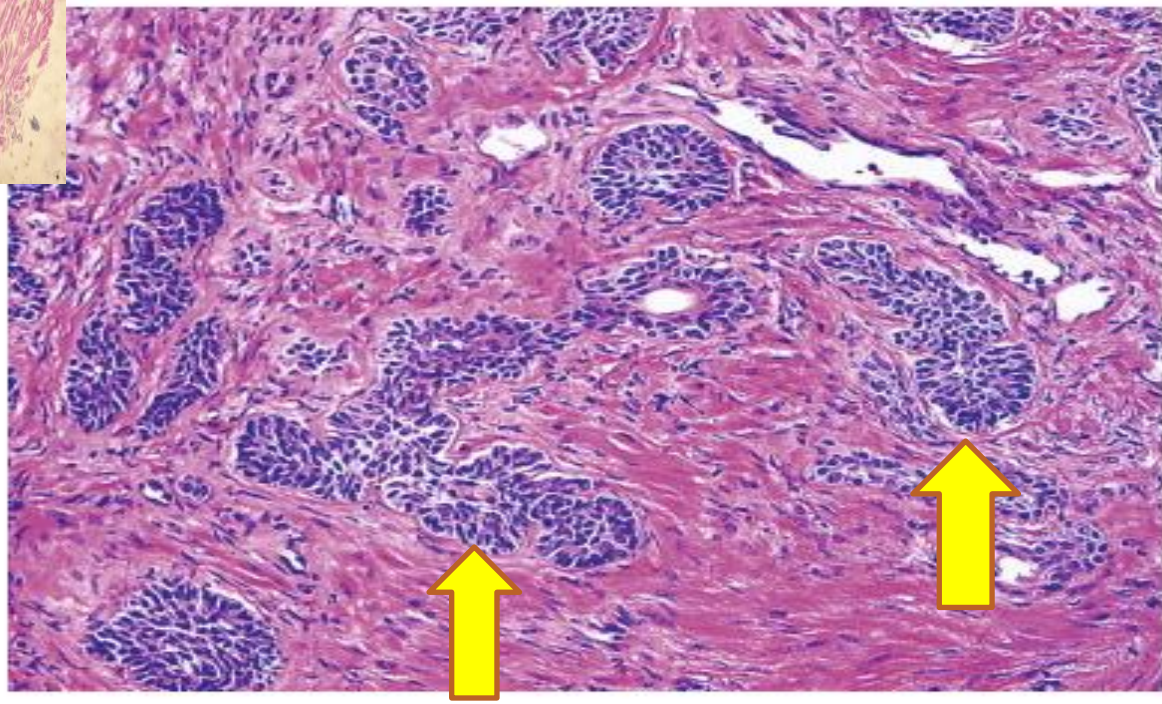


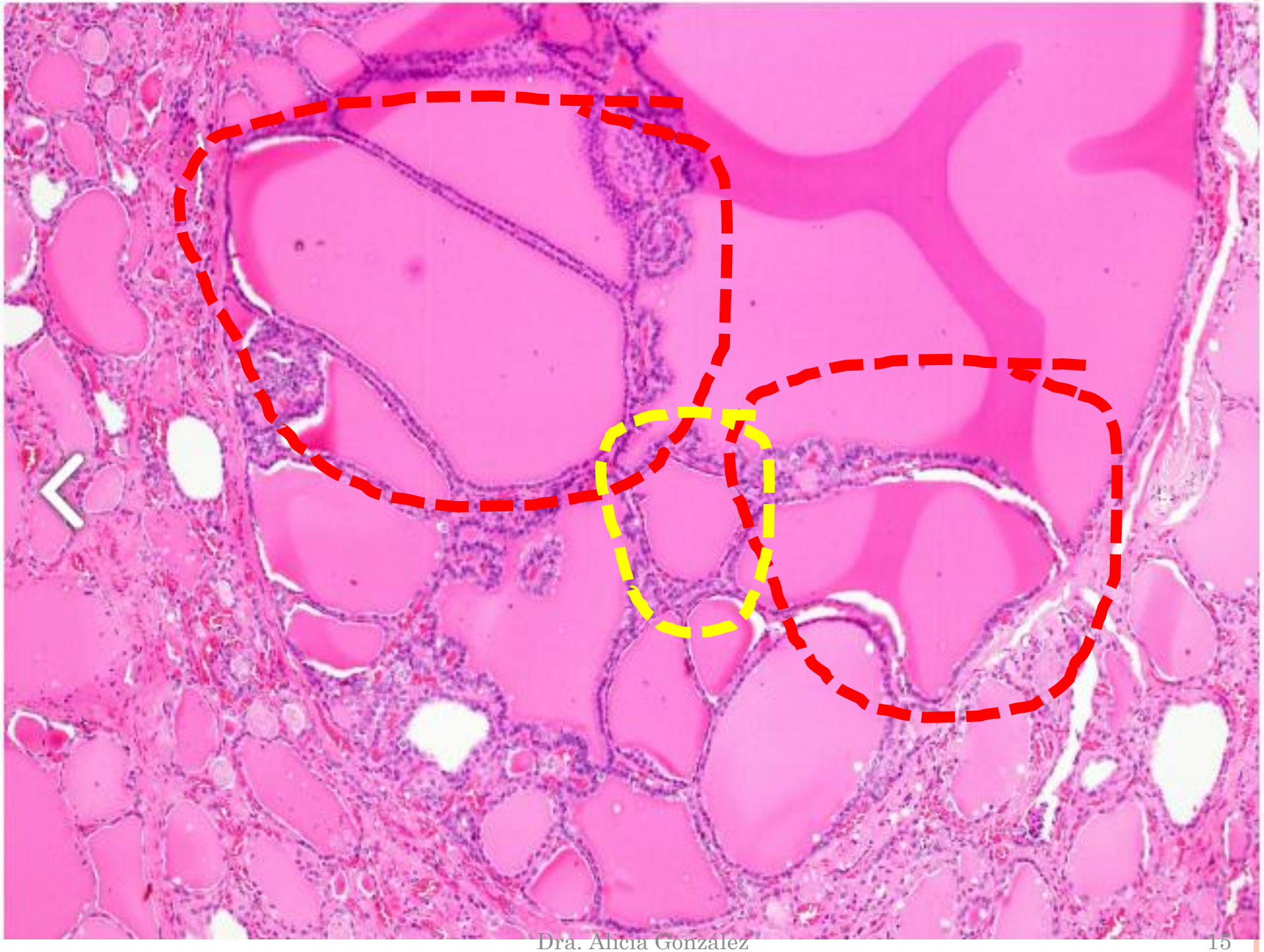
Fig. 18.8 Basal cell hyperplasia of prostate. The low-power architecture is cha



HIPERPLASIA FOLICULAR

- El aumento de la secreción de TSH es la principal causa en el bocio relacionado con la deficiencia de yodo, la tiroiditis autoinmune (Hashimoto), la enfermedad de graves; en personas con TSH normal, el daño oxidativo a las células foliculares y luego el daño al ADN conduce a hiperplasia





HIPERTROFIA:

Se refiere al **aumento de tamaño de las células** que da lugar a un **aumento en el tamaño de los órganos**. Así, pues el órgano hipertrofiado no tiene células nuevas sino células mayores.

El aumento de tamaño no se debe a la hinchazón, sino a la **sintésis de más componentes estructurales**

Las células **capaces de división** pueden responder a hiperplasia y también a hipertrofia mientras que las células que no se dividen como **las miocardicas ocurre la hipertrofia**


METRIC 1
2



Dra. Alicia González/
ali.glez2303@gmail.com

- Láminas a trabajar hoy:
- Hiperplasia Prostática Benigna
- Bocio Coloide Multinodular
- Hipertrofia Cardíaca

Dra. Alicia González/
ali.glez2303@gmail.com

Hiperplasia Prostática Benigna

1-Órgano: Próstata

2-PROCESO: ADAPTATIVO/ INFLAMATORIO CRONICO

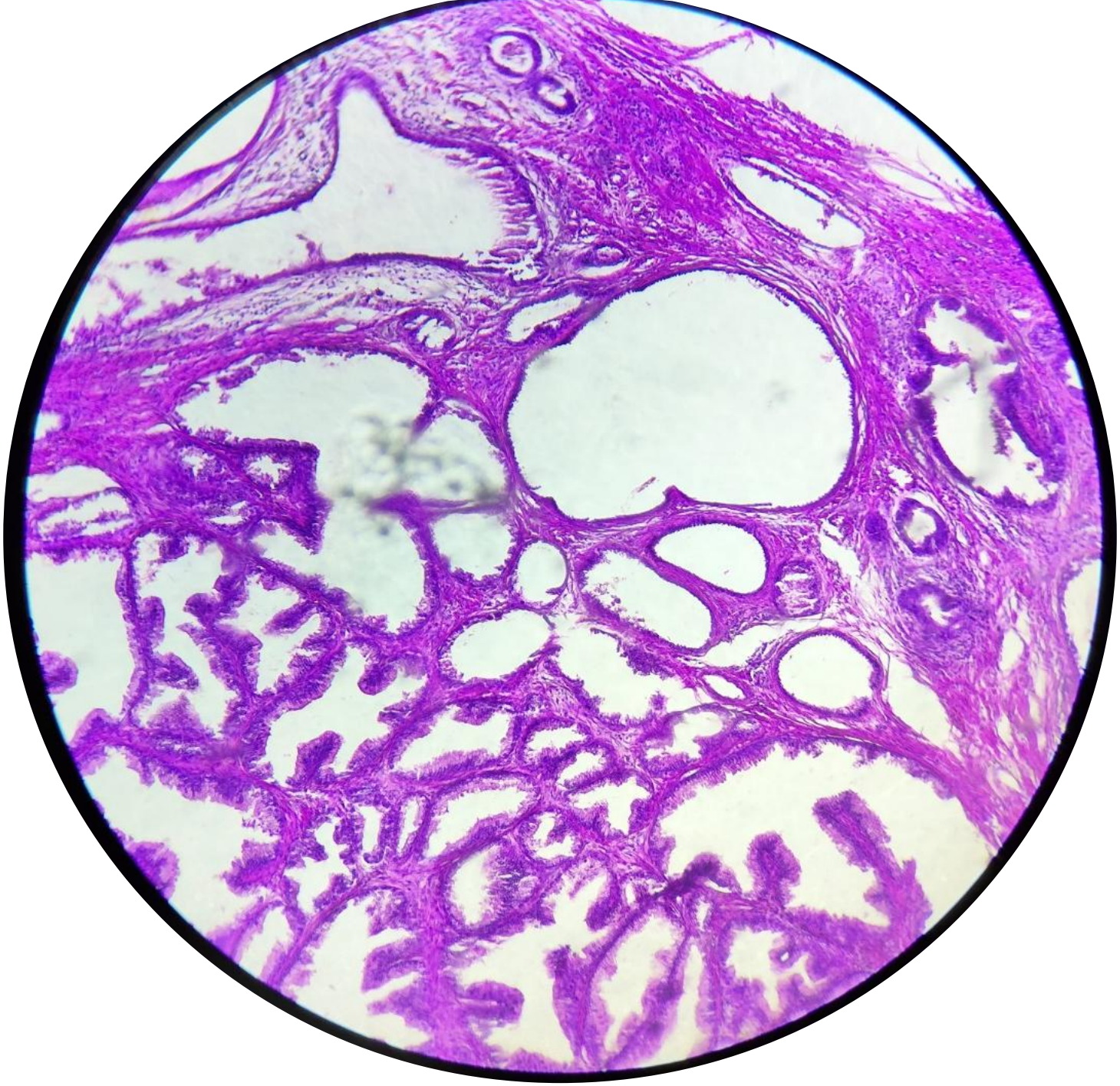
3-Alteraciones: Proliferación de glándulas benignas, con aumento del número de células en sectores. Se observan además dilataciones glandulares, invaginaciones papilares, y áreas quísticas con cuerpos amiláceos.

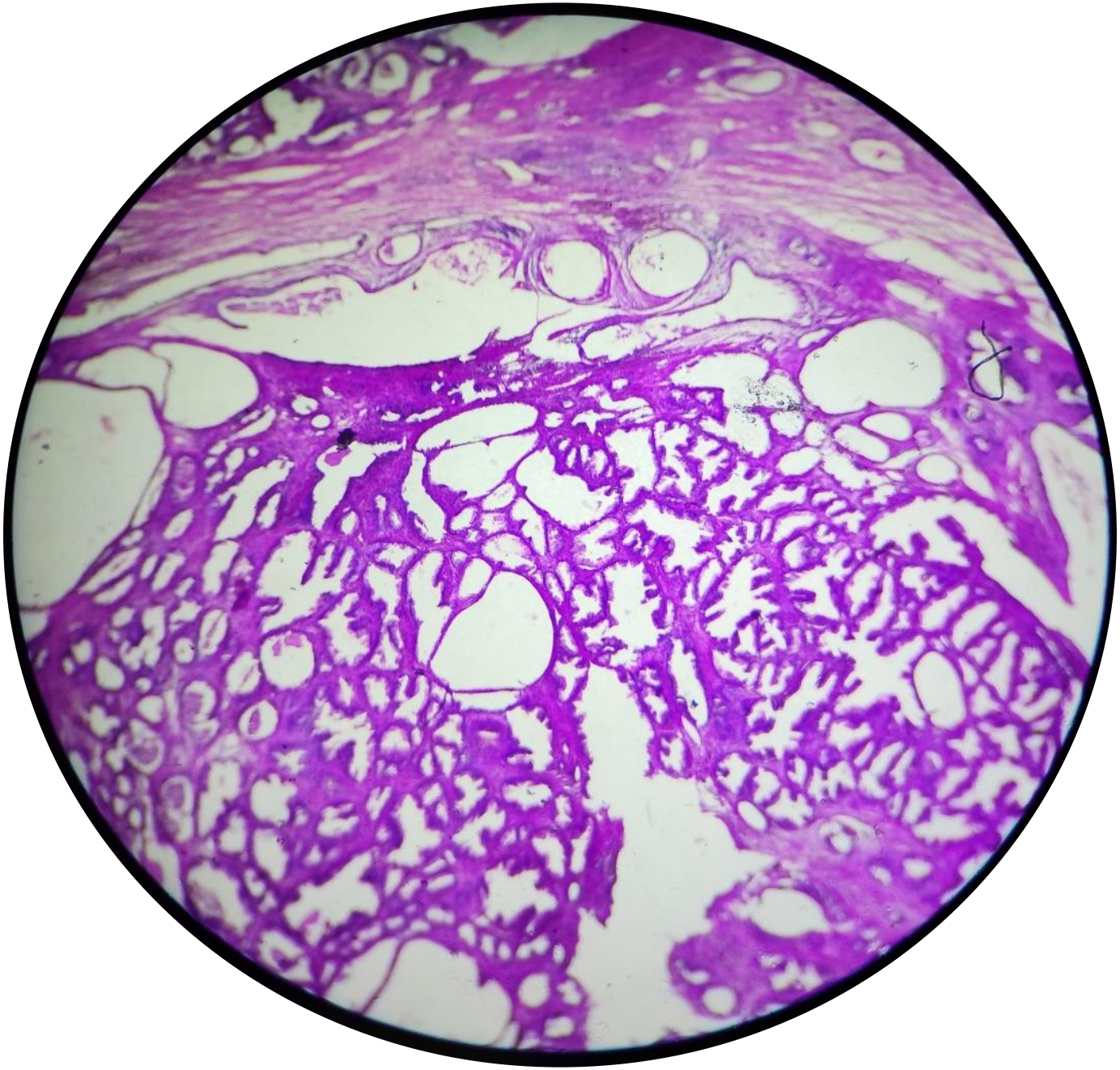
Se observa además infiltrado inflamatorio crónico sobre-agreagregado.

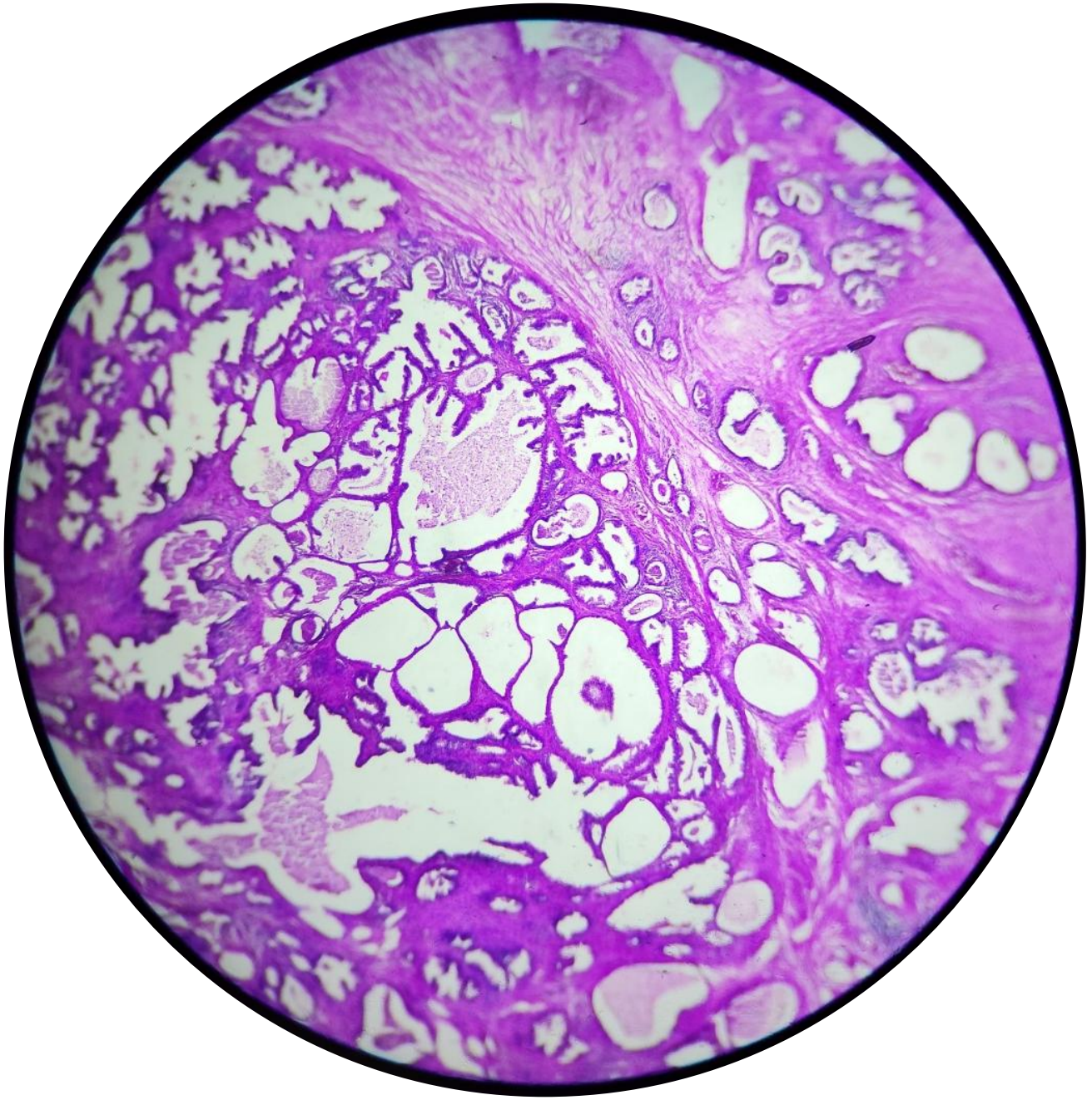
4-Diagnostico: Hiperplasia Prostática Benigna

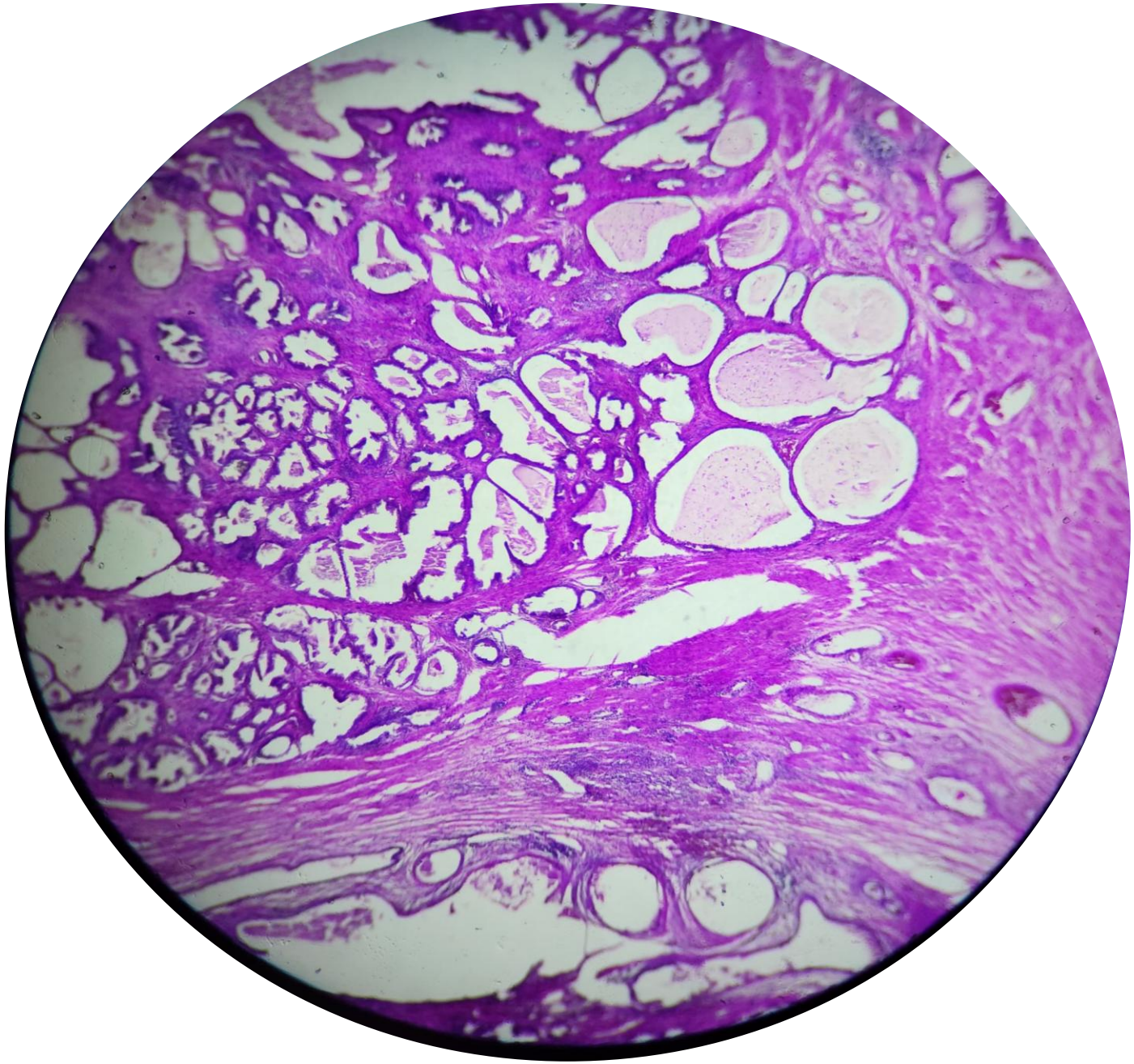
Prostatitis crónica.









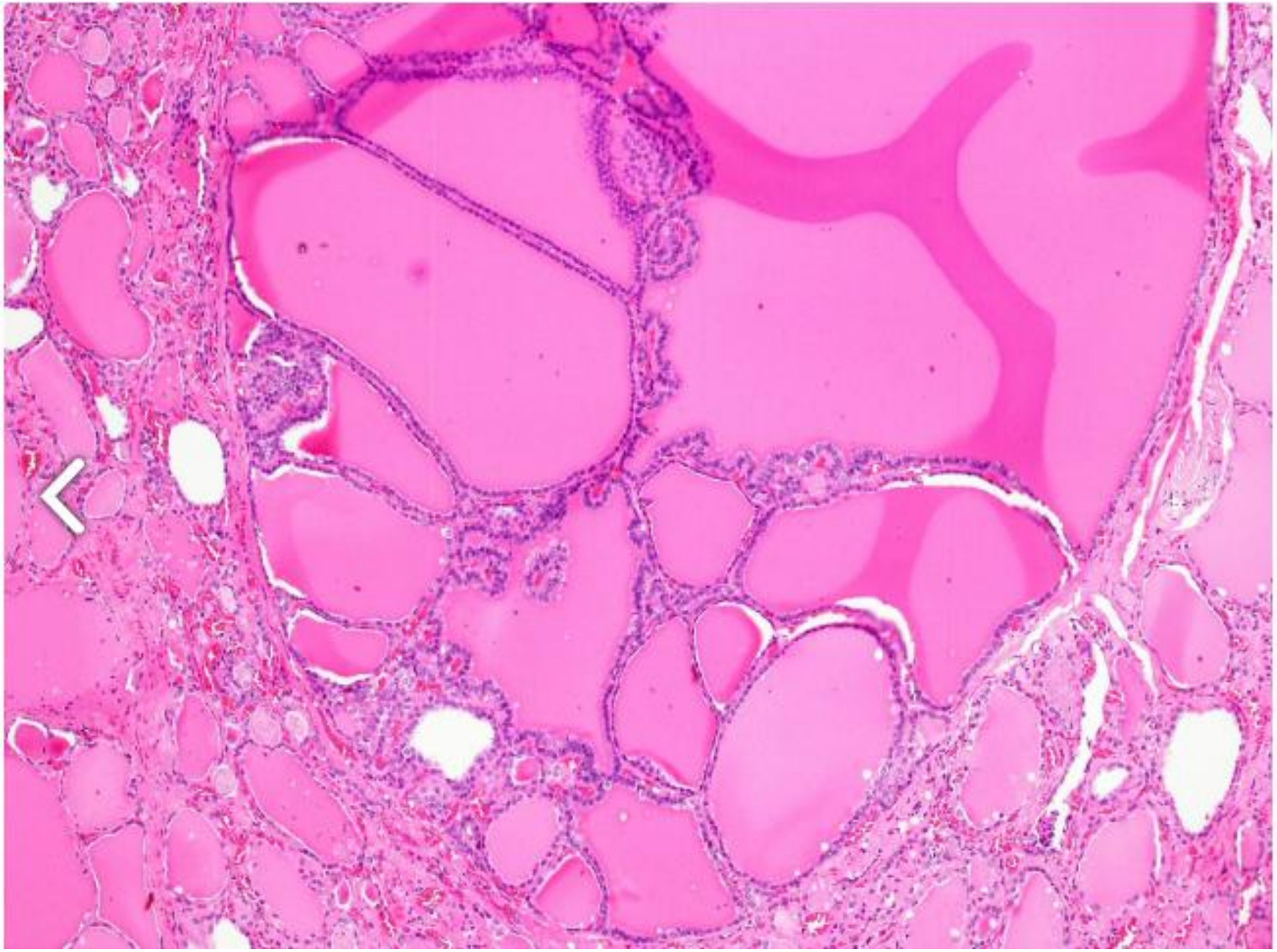


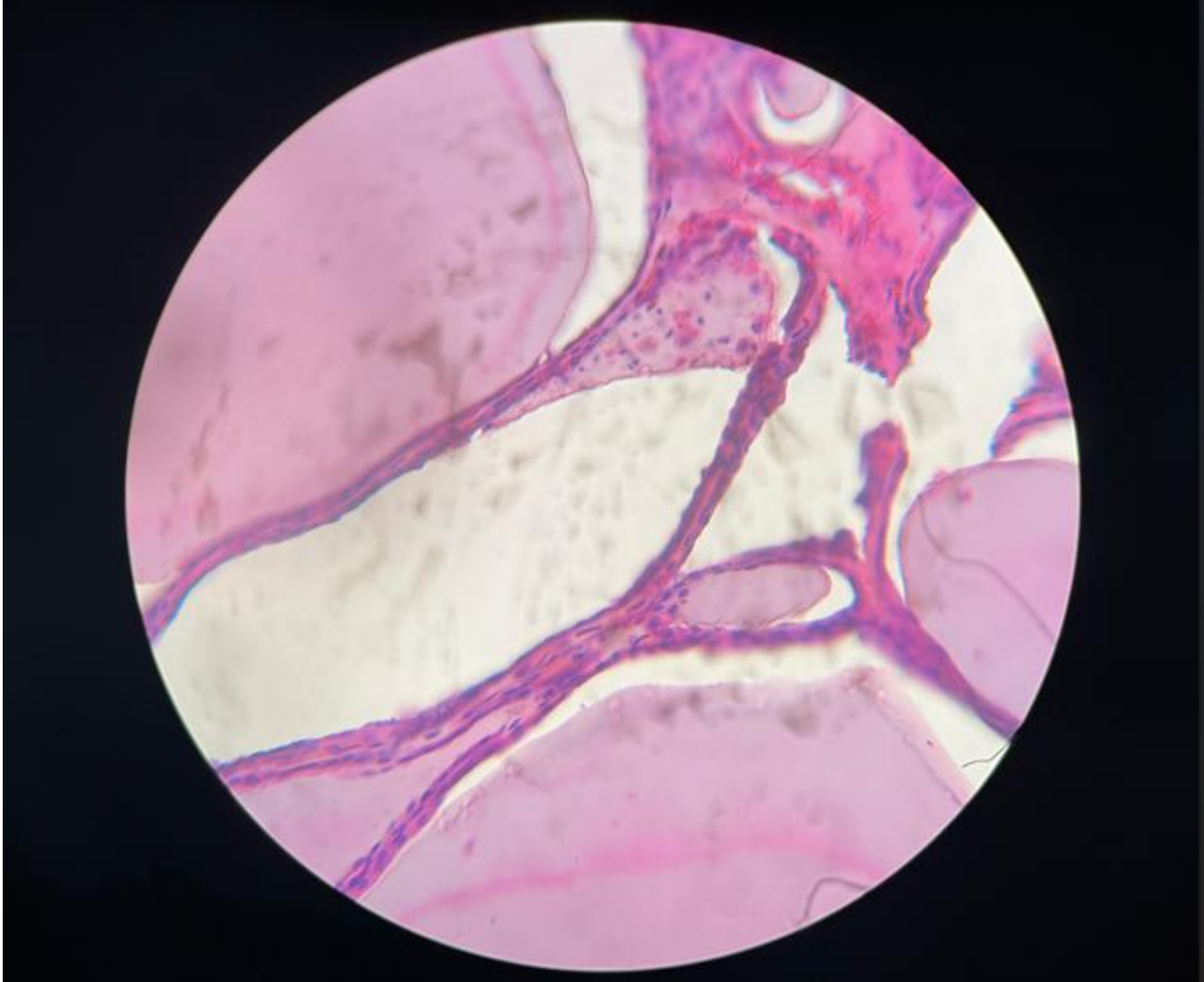
Órgano: Glándula Tiroides

- Proceso: Adaptativo

- Alteraciones: Folículos dilatados de tamaño variable , aplanado en sectores e hiperplásico en otros. Se observa además áreas de hemorragia

- DX PRESUNTIVO: Bocio Coloide Multinodular



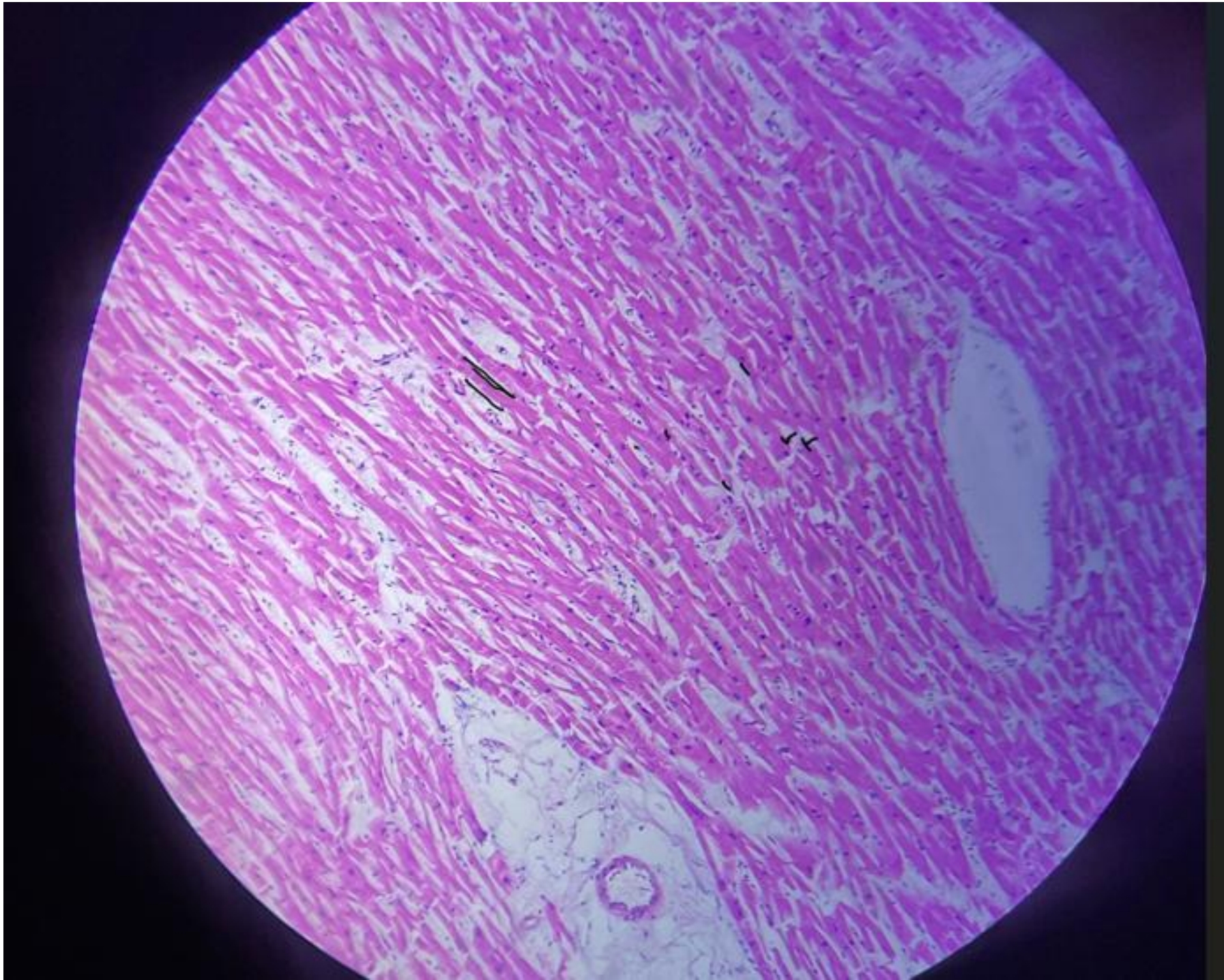


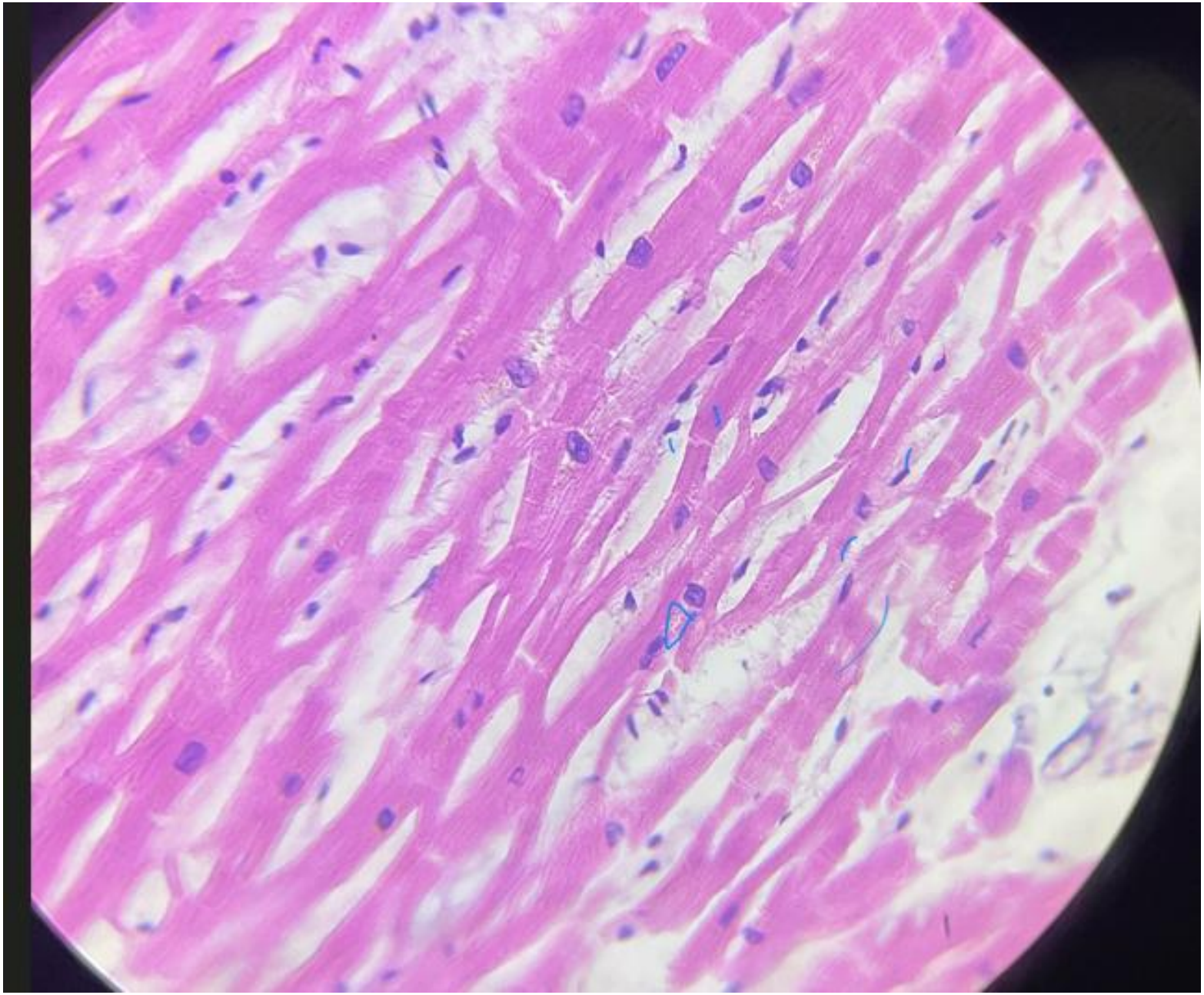
- ORGANO: CORAZON

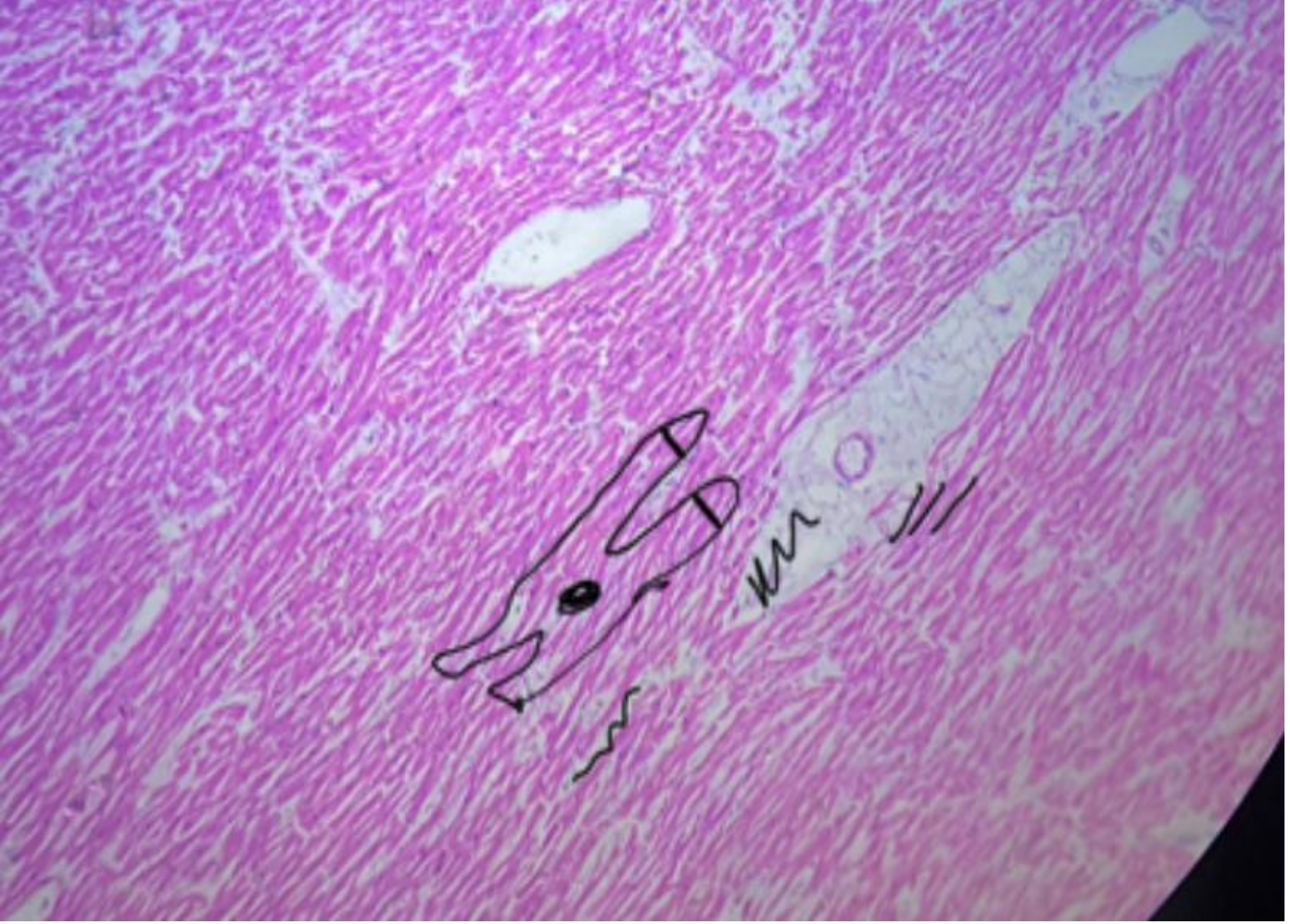
- PROCESO: ADAPTATIVO

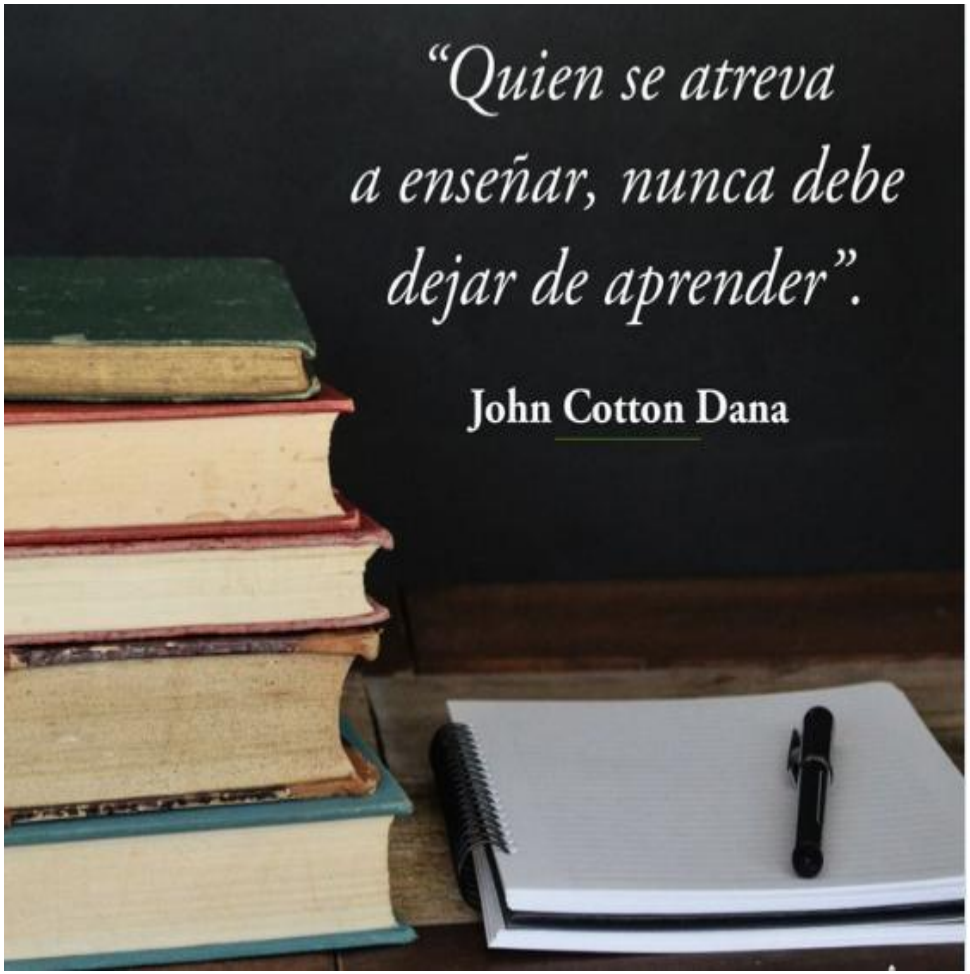
- ALTERACIONES: tejido muscular cardíaco con células hipertróficas (cardiomiocitos), anormalmente ramificados, con núcleos hipercromáticos y agrandados, de disposición irregular. Se observan además áreas de fibrosis cicatricial y pigmentos de lipofucsina.

- DX PRESUNTIVO: Hipertrofia Cardíaca



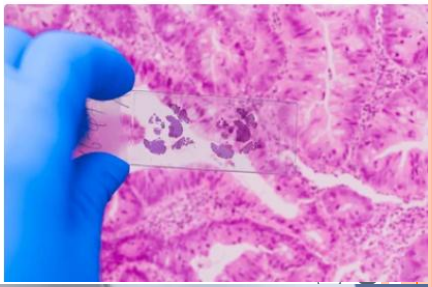






Gracias por su atención!!

Bienvenidos al mundo maravilloso de la patología!!!!



LA PATOLOGIA ES EL ARTE DE MIRAR..



